

정기감사  
공개용

# 양산부산대학교병원 보험관리팀 감사결과 보고서



2025. 8. 12.

부 산 대 학 교 병 원 감 사 실



## 차 례

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>I . 감사실시 개요</b>                | <b>3</b>  |
| 1. 감사배경 및 목적                      | 3         |
| 2. 감사중점 및 대상                      | 3         |
| 3. 감사실시 과정                        | 3         |
| 4. 감사결과 처리                        | 4         |
| <b>II . 감사대상 현황</b>               | <b>5</b>  |
| 1. 부서운영 분야                        | 5         |
| 2. 주요업무 분야                        | 7         |
| 3. 우수 업무 사례                       | 11        |
| <b>III . 감사 결과</b>                | <b>15</b> |
| 감사결과                              | 15        |
| <b>IV . 처분요구와 통보사항</b>            | <b>17</b> |
| 1. 처분요구사항 일람표                     | 17        |
| 2. 처분요구상세                         | 17        |
| 가. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 심사불능 건에 관한 사항       | 18        |
| 나. 자동차보험 환자진료비 미수금 관리 미흡          | 20        |
| 다. 비급여·요양급여100/100(전액본인부담)에 관한 사항 | 23        |
| 라. 퇴원 후 진료비 조정에 관한 사항             | 25        |
| 마. 진료비 고액 삭감 관리에 관한 사항            | 28        |
| 바. 산정특례 적용 착오 건 관리에 관한 사항         | 32        |
| 사. HLA교차 시험 검사비 입금 관리 미흡          | 36        |
| 아. 보험관리팀 소관 규정 관리에 관한 사항          | 39        |

## I 감사실시 개요

### 1. 감사배경 및 목적

부산대학교병원 감사실은 양산부산대학교병원 보험관리팀(이하 ‘보험관리팀’이라 한다)의 주기능·주임무와 조직, 인사, 예산 등 업무 전반의 적법성, 타당성 등을 점검하고 업무상 고충과 불합리한 관행, 업무 시스템의 취약점 등 문제점에 대한 시정 및 개선 대안을 제시함으로써 업무의 효율성과 합리성을 높이고, 궁극적으로 병원 경영을 지원하기 위하여 2025년도 부산대학교병원 감사실 자체 감사계획에 따라 보험관리팀에 대한 정기감사를 실시하였다.

### 2. 감사중점 및 대상

이번 감사는 보험관리팀 현안사항 중 제도적·정책적으로 대안 제시가 필요한 부분을 찾아내고 합리적인 제도 개선을 통해 부서 업무를 지원할 수 있도록 하는데 감사의 중점을 두었다. 따라서 보험관리팀에서 제출한 감사자료<sup>1)</sup>를 토대로 주요 업무 수행 과정이 관련 법령 및 병원 규정과 정책 등을 준수하는지 여부, 종전 정기감사 지적사항에 대한 이행 여부 등을 확인하고, 더불어 소속 직원들에 대한 복무관리 실태, 부서 예산 집행내역 등과 같은 부서 운영의 적정성도 점검하였다. 감사 범위는 보험관리팀에서 2022. 1. 1.부터 2024. 12. 31.까지 수행한 업무에 한하여 검토하였다.

### 3. 감사실시 과정

실지감사에 앞서 기존의 감사결과 및 공공감사정보시스템, 공공기관 알리오 등을 통하여 감사 자료를 수집·분석했고, 이후 예비조사(2025. 6. 30. ~ 2025. 7. 4.)를 거쳐 2025. 7. 7.부터 2025. 7. 18.까지 10일간 감사인원 9명을

1) 양산 보험관리팀-3828(2025.06.30.)

투입하여 실지감사를 실시하였다.

보험관리팀의 분야별 주요 쟁점을 확인하기 위해 ①해당 부서의 업무분장 사항을 중점적으로 확인하였고, 그 외 업무에 수반되는 행정지원 전반에 관한 사항 등도 제공받은 서류와 전자문서를 열람하여 검토하였다. 또한 ②부서 운영의 적정성을 확인하기 위해 경비정산 내역 및 예산 관리 현황을 점검했으며, ③복무관리 실태를 점검하기 위해 양산부산대학교병원 그룹웨어 및 병원정보시스템인 ‘YES’에서 출장·휴가 등의 데이터를 추출하여 활용하였다.

#### 4. 감사결과 처리

감사결과, 개선사항 및 시정·관리가 요구되는 사항 등에 관련하여 보험관리팀으로부터 의견을 듣고 이견을 조정하기 위해 보험관리팀장 등이 참석한 가운데 2025. 7. 18.(금) 감사마감 회의를 실시하고 주요 지적사항 등에 대한 의견을 교환하였다. 이후 감사실에서는 지적사항에 대한 내부 검토 및 상임감사의 결재(2025. 8. 12.(화))를 거쳐 감사결과를 최종 확정하였다.

## II 감사대상 현황

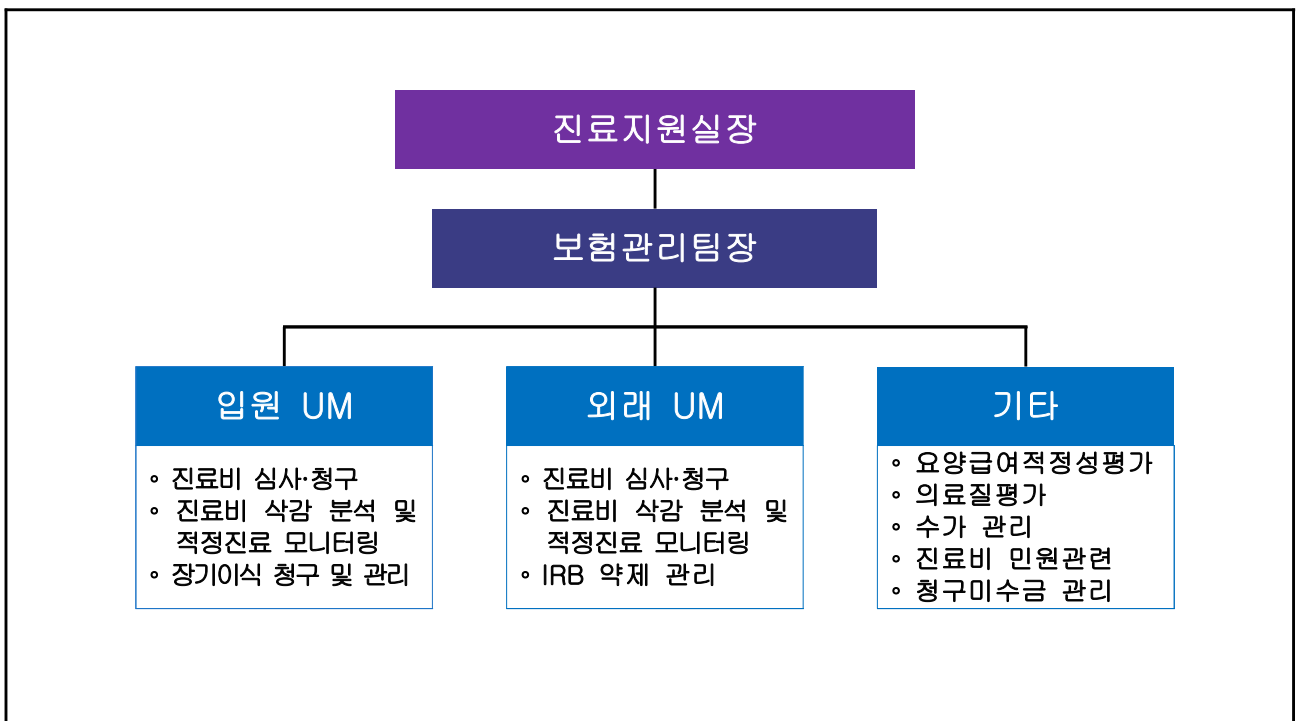
### 1. 부서운영 분야

#### 가. 조직·인원 현황

보험관리팀은 급변화하는 의료환경에 맞춰 건강보험제도와 관련된 정보를 수집하여 교육 및 홍보활동을 통해 적정진료를 유도하고, 또한 진료내역 심사·조정, 진료비 청구, 삭감관리 등 진료비 관리업무를 수행하는 부서로서 「양산 부산대학교병원 직제규정」 제7조(진료지원부서)에 따라 진료지원실 밑에 설치되어 있다.

조직 구성원은 팀장 1명, UM 2명, 팀원 27명 등 총 30명(현재 기준)으로 구성되어 있으며 조직도는 [그림 1], 인력 현황은 [표 1]과 같다.

[그림 1] 보험관리팀 조직도



**[표 1] 보험관리팀 인력 현황**

(단위: 명)

| 연도   | 구분  | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 소계 | 계약직 | 총계 |
|------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 2022 | 간호직 |    | 4  | 18 |    |    | 22 |     | 22 |
|      | 행정직 |    |    |    | 2  | 2  | 4  |     | 4  |
|      | 합계  |    | 4  | 18 | 2  | 2  | 26 |     | 26 |
| 2023 | 간호직 |    | 5  | 21 |    |    | 26 |     | 26 |
|      | 행정직 |    |    |    | 1  | 2  | 3  |     | 3  |
|      | 합계  |    | 5  | 21 | 1  | 2  | 29 |     | 29 |
| 2024 | 간호직 | 1  | 6  | 21 |    |    | 28 |     | 28 |
|      | 행정직 |    |    |    | 2  | 1  | 3  |     | 3  |
|      | 합계  | 1  | 6  | 21 | 2  | 1  | 31 |     | 31 |

※ 기준일: 각 연도별 12. 31.(휴직자 포함)

## 나. 부서예산 현황

최근 3년간 보험관리팀의 예산 배정 및 집행내역을 확인한 결과는 [표 2]와 같다.

**[표 2] 보험관리팀 예산집행 현황**

(단위: 원, %)

| 연도 \ 구분 | 예산액       | 집행액     | 잔액        | 집행률 |
|---------|-----------|---------|-----------|-----|
| 2022    | 5,440,000 | 627,130 | 4,812,870 | 12% |
| 2023    | 4,464,000 | 953,840 | 3,510,160 | 21% |
| 2024    | 4,076,000 | 291,200 | 3,784,800 | 7%  |

※ 집행률이 저조한 사유

|         |                                                                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기타지급수수료 | (2022년~2024년) 자동차보험 분쟁심의 건 감소 및 병원측 심사청구결정으로 그에 따른 자동차보험 진료수가분쟁심의회 추가비용 미발생                                                         |
| 도서구입비   | (2022년~2023년) 매년 보험업무관련 수가책자 구매비용 40만원~60만원 구매해 왔으나, 무료배부권수가 매년 변동되어 책자 수량 및 단가 매년 변동<br>(2024년)비상경영으로 보험업무관련 수가책자 무료배부권수 외 추가분 미구매 |
| 기타행사비   | (2022년~2024년) 영양기관 현지실태조사 미실시                                                                                                       |
| 회의비     | (2022년~2023년) 코로나19로 인한 서면심의 대체 및 대면회의 축소<br>(2024년)비상경영으로 서면심의 대체 및 회의비 지출 최소화                                                     |

## 2. 주요업무 분야

### 가. 주요업무 내용

보험관리팀 주요업무는 [표 3]과 같다.

**[표 3] 보험관리팀 주요업무 내용**

| 주요업무                | 세부내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 의료정보 수집 및 교육        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 보험 진료비 심사와 관련된 정보의 수집, 홍보 및 교육에 관한 사항</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |
| 진료내역 심사 및 청구        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 각종 보험 진료비 심사결과에 대한 자문 및 건의에 관한 사항</li> <li>• 진료내역 심사 및 진료비 청구에 관한 사항</li> <li>• 진료비 청구 후 삭감 및 이의신청 처리에 관한 사항</li> <li>• 입원 및 외래환자 사후 심사에 의한 진료내역 조정에 관한 사항</li> <li>• 환자의 보험진료비 명세서 발급에 관한 사항</li> <li>• 공상환자 진료비 청구 및 관리에 관한 사항</li> <li>• 진료비 민원에 관한 사항</li> </ul> |
| 청구미수금 관리            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 진료비 청구 미수액 관리 및 청구통계에 관한 사항</li> <li>• 기타 각종 보험과 관련된 사항</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |
| 의료수가 관리             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 의료수가 책정 및 수가기준의 관리, 조정, 적정성 분석 및 개선에 관한 사항</li> <li>• 의료행위의 표준화 및 세분화에 관한 사항</li> <li>• 진료재료대(의약품 포함) 구입·소명자료 제출에 관한 사항</li> </ul>                                                                                                                                   |
| 심평원 진료비 확인          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 심평원의 비급여 진료비 적정성 확인에 관한 사항</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                |
| 요양적정성 평가 /<br>의료질평가 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 요양적정성 평가 및 의료질평가에 관한 사항</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   |

## 나. 주요업무 추진실적

최근 3년간 보험관리팀의 주요업무 추진실적은 [표 4]와 같다.

**[표 4] 보험관리팀 주요업무 추진실적**

| 연도   | 건명 및 사업내용                                 | 사업목적                                                                  | 현황 및 실적                                                                                                            | 성과                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022 | 삭감률 감소활동<br>[‘처방연동 팝업 설정’ 화면 신설]          | 변화하는 보험 심사 기준에 대한 정보를 진료과에 공유하고, 삭감현황에 대한 피드백을 제공하여 의료진의 이해를 돕고, 개선유도 | -삭감발생시 실시간으로 데이터를 분석하여 의료진 처방시 잘못된 처방에 대해 막거나 알려주고, 올바른 처방을 유도함<br>-점진적으로 항목수 확대 중이며, 2025년 6월 현재 130개 항목에 대해 관리중임 | -2022년 연평균 삭감률 0.36%[2021년 연평균 삭감률(0.41%)보다 감소]<br>-재정적 손실감소<br>-삭감발생 감소로 불필요한 재심사 요청이나, 소명자료 준비등의 업무를 줄여 의료진의 행정적 업무부담 경감                 |
|      | 입원전문질환군 관리                                | 상급종합지정평가 및 의료질평가 지표인 입원전문질환군 관리목적                                     | -퇴원심사 완료클릭 시 KDRG 분류 저장되도록 개선<br>-제5기 상급종합병원 지정평가 준비 TFT에 지표결과 보고                                                  | 전문질환군비율 향상 위한 개선활동 기초자료제공                                                                                                                  |
|      | 격리실 입원료 발생 전산개발                           | 심사자 수기 조정→ 전산 자동발생                                                    | 2022.10.1.부터 간호단위에서 격리 사유 체크 시 격리실 입원료 수가 자동 발생하도록 전산개발                                                            | -일반병동 야간간호료수가 등 통계처리 오차 감소<br>-격리 사유 및 기간을 빠르게 확인할 수 있어 심사 업무 효율성 증가<br>-입원료에 따라 자동발생되는 연관수가들이 심사자 수기 조정으로 인해 발생할 수 있었던 수가 누락 및 오류 가능성 없어짐 |
| 2023 | 삭감률 감소활동<br>[‘환자별 수가관리 마스터조회 및 수정’ 화면 개정] | 활용도를 확대하여 의료진에게 해당 환자 처방 관련 소통을 할 수 있도록 채널 활성화                        | 기존 해당 환자의 삭감 데이터를 등록해두고, 동일한 처방을 낼 때 처방을 제한하는 방식이었으나 삭감데이터뿐 아니라 해당 환자의 처방관련하여 의료진에게 알릴 내용 있을 시에도 사용하여 활용도를 확대함     | -2023년 연평균 삭감률 0.37%<br>-의료진의 보험청구 및 심사기준에 대한 이해도가 높아지고 자체 검토가 강화                                                                          |

| 연도   | 건명 및 사업내용                           | 사업목적                                                                                     | 현황 및 실적                                                                                                                                                                                                              | 성과                                                                                                                                       |
|------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 청구기간 단축                             | 진료비 조기회수                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>-2020년부터 분리청구관련해서 물류관리팀, 회계관리팀, 정보전산팀 및 물류집계관련 실무부서(수술실, 심혈관센터 등)와 업무협의를 진행</li> <li>-물류 마감집계, 재료신고 등 관련 전산 개선</li> <li>-2023년 6월부터 입원 월 2회 청구(건강보험) 적용</li> </ul>            | 당월 1일~15일 퇴원(건강보험)건 당월 25일경 1회차로 청구                                                                                                      |
|      | POA 청구정확도 관리                        | 의료질평가지표관리                                                                                | 청구생성상병 POA 값과 보건의료정보팀 퇴원분석 POA 값을 비교하여 불일치 여부 확인 프로그램 신설                                                                                                                                                             | POA 청구정확도 지표 만점 유지                                                                                                                       |
|      | 입원전문질환군 관리                          | 상급종합지정평가 및 의료질평가 지표인 입원전문질환군 관리목적                                                        | 청구명세서 생성시 상병코드와 보건의료정보팀 권고상병코드랑 불일치하는 경우 청구회차 분리하여 진료의 상병코드 수정 확인 후 청구                                                                                                                                               | 5기 상종지정평가 입원전문질환군 지표 만점                                                                                                                  |
|      | 의료질 및 영양급여 적정성 평가 대비 활동(적정관리팀 업무이관) | <ul style="list-style-type: none"> <li>-의료질평가 1-나등급 획득</li> <li>-적정성평가 1등급 획득</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-의료질평가: 1-나등급</li> <li>-적정성평가: 1등급 (COPD, 결핵, 약제급여, 폐렴, 정신건강입원영역)</li> </ul>                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-의료질평가 1-나 등급 획득</li> <li>-적정성평가 1등급 유지</li> </ul>                                                |
| 2024 | 삭감을 감소활동<br>[‘항암프로토콜 시작일 조회’ 화면 신설] | 삭감 예측건에 대해 잠재적 삭감위험을 미리 감지하고, 선제적 대응이 가능하도록 함                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>-외래청구명세서 생성전에 빠르게 항암제 처방을 심사하고 연계 삭감을 줄이기 위하여 스탠트 항암제 처방건에 대해 조회할 수 있는 화면을 생성</li> <li>-처방일 익일 해당심사자가 항암요법의 급여기준을 확인하여, 기준 미충족 시 진료과에 피드백을 제공하여 관련자료 보완 및 처방중단을 유도</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-2024년 연평균 삭감을 0.37%</li> <li>-삭감발생감소로 불필요한 재심사 요청이나 소명자료 준비등의 업무를 줄여 의료진의 행정적 업무부담 경감</li> </ul> |
|      | 삭감을 감소활동<br>[청구진료비 삭감감소 개선회의]       | 고가 재료 및 약제, 반복적으로 수술료가 삭감이 되는 주요 진료과와의 개선방안 논의통해 삭감감소를 하고자 함                             | 청구진료비 삭감감소 개선회의(기획예산팀 협업): 2024년 8월부터 삭감률이 높은 4개 진료과(신경외과, 외과, 심장혈관흉부외과, 호흡기내과) 대상으로 과별 삭감경향 분석, 피드백 제공, 급여기준 안내, 애로점 공유 등 삭감감소를 위한 개선책 모색                                                                           |                                                                                                                                          |

| 연도 | 건명 및 사업내용               | 사업목적                             | 현황 및 실적                                                                                                       | 성과                                                                    |
|----|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|    | 입원전문질환군 관리              | 상급종합지정평가 및 의료질평가 지표인 입원전문질환군 관리  | 청구명세서 생성시 상병코드와 보건의료정보팀 권고상병코드랑 불일치하는 경우 청구회차 분리하여 진료의 상병코드 수정 확인 후 청구                                        | 보건의료정보팀과 청구상병 일치 및 입원전문질환군 비율관리                                       |
|    | 보험관리팀 업무지침서 개정          | 전문성 강화                           | 기존 업무지침서에서 실무 부분 추가하여 개정 진행                                                                                   | 2025년 6월 개정                                                           |
|    | 그룹웨어-수가정보 게시판 신설        | 최신 수가 정보의 효율적 제공                 | 기존에 지침서 형태로 각 부서에 제공하던 수가 정보를 그룹웨어-간호부 수가정보게시판을 신설하고 정보를 제공함에 따라 최신의 수가정보 제공 가능                               | -수가산정에 대한 이해도 및 관심도 증가<br>-간호수가산정 누락 및 오류 감소<br>-간호현장에서 산정가능 수가 개발 유도 |
|    | 원 외 처방 약 제비 환수금 회수소송진행  | 재정 손실 감소                         | 고객행복팀 분쟁담당자 소송신청 진행중임                                                                                         | -                                                                     |
|    | 산정특례 적용 착오율 감소 활동       | 무인수납률의 증가로 발생하는 수납 오류를 감소        | 환자 정보 및 진료정보, 동일 진료과/주치의 이전 수납 정보를 복합적으로 읽어 불일치건에 대해 확인하는 작업을 시행                                              | -수납 오류율 감소<br>-환자 만족도 향상<br>-재정적 손실 감소 및 정산 효율 증대<br>-산정특례 적용착오율 감소유도 |
|    | 의료질 및 영양급여 적정성 평가 대비 활동 | -의료질평가 1-나등급 획득<br>-적정성평가 1등급 획득 | -의료질평가: 1-나등급<br>-적정성평가: 1등급 (COPD, 결핵, 약제급여, 관상동맥우회술, 급성기 뇌졸중, 대장암, 폐암, 위암, 수혈, 수술예방적항생제, 마취, 중환자실, 신생아중환자실) | -의료질평가 1-나 등급 획득<br>-적정성평가 1등급 유지                                     |

## 다. 부서운영경비 사용 현황

최근 3년간 보험관리팀의 부서운영경비 사용 현황은 [표 5]와 같다.

[표 5] 보험관리팀 부서운영경비 사용 현황

(단위: 천원, %)

| 연도<br>업무추진비내역 | 2022  |       |     | 2023  |       |     | 2024  |       |     |
|---------------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|
|               | 수입    | 비용    | 집행률 | 수입    | 비용    | 집행률 | 수입    | 비용    | 집행률 |
| 부서운영경비        | 5,470 | 5,744 | 105 | 6,855 | 7,249 | 106 | 7,035 | 7,480 | 106 |

### 3. 우수 업무 사례

#### ▣ 「항암프로토콜 시작일 조회」 프로그램 신설

##### □ 목적

- 삭감 예측 건에 대해 잠재적 삭감위험을 미리 감지하고, 선제적 대응을 하여 항암 연계 삭감을 줄이고자 함

##### □ 추진배경

- 외래청구 명세서는 진료일 기준 익월 1일에 생성됨에 따라 심사가 즉각적으로 이루어지지 못해 삭감이 예측되는 처방의 발견 시점이 늦음
- 항암제 처방의 특성상 고가 약제의 연계투여로 인해 삭감 시 병원의 재정적 손실부분이 크게 작용
- 처방일에 최대한 가깝게 급여기준을 심사하여 예측되는 삭감 건을 줄이고자 하는 필요성 인지
- 처방되는 모든 항암제를 매일 확인하는 것은 인적 · 시간적 차원에서 불가능함에 따라 항암 regimen(요법)이 바뀌는 시점에 급여기준을 확인하는 것이 효율적임을 판단함

##### □ 개선활동

- 항암 연계삭감을 줄이고자 정보전산팀과 협의하여 병원정보시스템(YES)을 활용하여 ‘항암프로토콜 시작일조회’ 프로그램 개발
- ‘항암제 치료환자 기록지’를 사용하는 진료과(혈액종양내과) 외래환자 대상으로 시행 (시행일자: 2024년 9월 1일부터)
- 업무흐름 및 활동내용 <그림 참조>

### ① 조회일자를 설정하여 심사 대상자 선정

**함암프로토콜 시작일 조회** 🔍 조회

2025-06-16 ~ 2025-06-16

| 등록번호 | 성명 | 진료과    | 시작일자       | 프로토콜명                      | 처방의사명 |
|------|----|--------|------------|----------------------------|-------|
|      |    | 혈액종양내과 | 2025-06-16 | Ramucirumab + w-paclitaxel |       |
|      |    | 혈액종양내과 | 2025-06-16 | Neoadj. docetaxel          |       |
|      |    | 혈액종양내과 | 2025-06-16 | lorlatinib                 |       |
|      |    | 혈액종양내과 | 2025-06-16 | nivo+FOLFOX                |       |



### ② 선정된 환자 함암제 치료 기록지와 의무기록 병행 검토

YES 함암제 치료환자 기록지 -- 웹 페이지 대화 상자

**기본정보**

| 등록번호 | 성명 | 나이 | 성별 | 진단명 |
|------|----|----|----|-----|
|      |    | 66 | M  |     |

**함암치료결과**

| 투약일                                 | 투약일자                 | 투약량     |
|-------------------------------------|----------------------|---------|
| 2025-06-16                          | #1                   |         |
| 함암제                                 | Nivolumab            | 240mg   |
|                                     | Oxipatin             | 161mg   |
|                                     | Leucovorin           | 380mg   |
|                                     | 5-FU (bolus)         | 760mg   |
|                                     | 5-FU (D1,2)          | 2280mg  |
| 비고                                  |                      |         |
| 치료반응평가                              | Overall Response     |         |
|                                     | ECOG PS              | 1       |
| 함암치료 부작용 (Hematologic toxicity)     | 신장(kg)               | 176cm   |
|                                     | 체중(kg)               | 73.25kg |
|                                     | BSA(m <sup>2</sup> ) | 1.9     |
|                                     | Anemia               | 0       |
| 함암치료 부작용 (Non-Hematologic toxicity) | Febrile neutropenia  | 0       |
|                                     | Neutropenia          | 0       |
|                                     | Thrombocytopenia     | 0       |
|                                     | Anorexia             | 0       |
| 함암치료 부작용 (Non-Hematologic toxicity) | Dianhea              | 0       |
|                                     | Fatigue/weakness     | 0/0     |
|                                     | Nausea               | 0       |
|                                     | Vomiting             | 0       |

**경과기록지 내역**

| 프로토콜        | 시작일        | 종료일 |
|-------------|------------|-----|
| nivo+FOLFOX | 2025-06-16 |     |

**함암치료 Regimen**

Nivolumab + FOLFLOX

•급여기준•

path 1차 : PD-L1 발현 양성(발현 비율 CPS≥5)인 건방

※ HER2 양성 제외

※ 선행화학요법/수술후보조요법, 근치적합암화학방사

D1

1) Nivolumab 240mg + NORMAL SALINE 100 ML B1

2) antiemetic : ALOXID 0.25 MG/5 ML 1Vial IV p.c.

3) DEXAMETHASONE 5 MG/1 ML 2 AMP IV + NOR

4) Oxipatin 85 mg/m<sup>2</sup> IV + DEXTROSE 5 % 500 I

5) Leucovorin 200 mg/m<sup>2</sup> + NORMAL SALINE 100 I

**명령 및 치료 요약**

비급여 설명: 환급+



### ③ 급여기준을 충족하지 못하거나, 소명자료가 부족한 경우 진료과에 피드백 제공

## □ 활동성과

- 혈액종양내과 외래 삭감율 감소 (0.738% → 0.078%)

| 구분        | 진료년월     | 청구총액           | 전체삭감액<br>(A) | 연계삭감액<br>(B) | 순수삭감액<br>(A-B) | 삭감율<br>(A/청구액) | 순수삭감율<br>(A-B/청구액) |
|-----------|----------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| 적용<br>(전) | 2024년01월 | 13,244,563,850 | 97,794,878   | 해당없음         | 97,794,878     | 0.738          | 0.738              |
|           | 2024년02월 |                |              |              |                |                |                    |
|           | 2024년03월 |                |              |              |                |                |                    |
|           | 2024년04월 |                |              |              |                |                |                    |
|           | 2024년05월 |                |              |              |                |                |                    |
|           | 2024년06월 |                |              |              |                |                |                    |
|           | 2024년07월 |                |              |              |                |                |                    |
|           | 2024년08월 |                |              |              |                |                |                    |
| 적용<br>(후) | 2024년09월 | 11,031,060,810 | 40,707,647   | 32,014,707   | 8,692,940      | 0.369          | 0.078              |
|           | 2024년10월 |                |              |              |                |                |                    |
|           | 2024년11월 |                |              |              |                |                |                    |
|           | 2024년12월 |                |              |              |                |                |                    |
|           | 2025년01월 |                |              |              |                |                |                    |
|           | 2025년02월 |                |              |              |                |                |                    |
|           | 2025년03월 |                |              |              |                |                |                    |
|           | 2025년04월 |                |              |              |                |                |                    |

### 삭감율 산정 기준

\*전체삭감액(A): 연계삭감 포함 총 삭감된 금액

\*연계삭감액(B): 프로그램 적용 전 처방이 이어져 발생한 삭감 금액

\*순수삭감액(A-B): 프로그램 직접 영향으로 삭감된 금액

\*삭감율: 전체삭감액/청구총액X100

\*순수삭감율: 순수삭감액/청구총액X100

→ 연계삭감: 프로그램 적용 전에 시작된 약제 처방이 적용 이후에도 이어지고, 급여 기준 미충족으로 연계되어 삭감된 경우

→ 이는 프로그램의 효과가 직접적으로 반영되지 않은 구간에서 발생했지만, 삭감 시점은 프로그램 적용 이후라는 특징이 있음

→ 연계삭감 건은 ‘프로그램 효과’의 직접적인 결과가 아니므로, 별도로 분리하여 분석하고 순수삭감율을 기준으로 비교하는 것이 프로그램 반영전후의 효과를 판단하는데 적합함

- 삭감율 감소로 병원의 재정적 손실 감소

- 삭감발생 감소로 불필요한 재심사 요청이나 소명자료 준비 등의 업무를 줄여 의료진의 행정적 업무 부담 감소

## □ 향후계획

- 현재 ‘항암제 치료환자 기록지’는 혈액종양내과 외 타 진료과는 해당 프로그램 적용하지 못하고 있어 향후 확대 적용을 목표로 함
- 차세대 전산도입 시에는 모든 진료과가 ‘항암제 치료환자 기록지’를 사용할 수 있도록 관련부서와 업무협의를 진행할 예정

### III 감사결과

감사결과 총 8건의 부당 · 개선 사항에 대한 처분을 종류별로 구분하면 [표 6]과 같으며, 확인된 주요 사항을 요약하여 정리하면 아래와 같다.

[표 6] 보험관리팀 지적사항 총괄

(단위: 건)

| 건수 | 합계 |    | 변상<br>명령<br>(금액) | 징계<br>(인원) | 시정<br>(금액) | 주의<br>(인원) | 경고<br>(인원) | 개선 | 권고 | 통보 |          |             |            |          | 고발<br>(인원) | 현지<br>조치 |
|----|----|----|------------------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|----------|-------------|------------|----------|------------|----------|
|    | 금액 | 인원 |                  |            |            |            |            |    |    | 일반 | 시정<br>완료 | 인사처<br>(인원) | 비위<br>(인원) | 모범<br>사례 |            |          |
| 8  | -  | -  | -                | -          | -          | -          | -          | 3  | 3  | 1  | 1        | -           | -          | -        | -          | -        |

#### 보험관리팀 감사결과 확인된 주요 사항

##### <감사지적 사항>

##### □ ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 심사불능 건에 관한 사항

- 전체 불능 건 2,882건(11,815,278,740원) 중 기관요청 및 자료미제출로 인한 반송 1,449건(7,260,929,330원)
- 기관요청 건 중 반송명세서 도착 전 재청구하여 중복청구로 재 반송된 건: 99건(23,172,920원)

##### □ 자동차보험 환자진료비 미수금 관리 미흡

- 지연입금 건에 대한 지연이자 미수령
- 지연입금 건수: 26건(최소 1일 ~ 최대 127일)

##### □ 비급여·요양급여 100/100(전액본인부담)에 관한 사항

- 비급여 또는 전액본인부담 항목임에도 급여로 청구되어 삭감
- 삭감건수: 2,742건 / 삭감금액: 292,162,173원

##### □ 퇴원 후 진료비 조정에 관한 사항

- 원무팀 미통보(구두 처리)
- 진료비 청구 전 발생 건에 대한 지연 청구
- 퇴원일 기준 30일 이후 청구된 건수: 1,556건(최소 31일 ~ 최대 443일)

##### □ 진료비 고액 삭감 관리에 관한 사항

- 진료비 고액 삭감에 대해 진료과 미통보(총 130건)
- 진료비 고액 삭감 관련 협조문(통보) 미작성(총 36건)

☐ 산정특례 적용 착오 건 관리에 관한 사항

- 2019년 정기감사 지적 이후에도 착오 건수 증가
- 산정특례 적용 착오 건에 대한 재정산 및 청구 지연 처리

☐ HLA교차시험 검사비 입금 관리 미흡

- 2022년 발생한 검사비 611,430원 미입금(감사결과 확정 전 입금 완료)

☐ 보험관리팀 소관 규정 관리에 관한 사항

- 기관 명칭 수정 및 현행업무에 맞게 제·개정 필요(규정과 별도로 운영)
- 규정상 결재선 미준수(수가신규 책정 시 사무국장 결재 누락)

**<우수 업무 사례>**

☐ 「항암프로토콜 시작일 조회」 프로그램 신설

- 삭감 예측 건에 대해 선제적 대응으로 항암 연계 삭감 줄임

보험관리팀에서는 항암제 처방 특성상 고가 약제의 연계투여로 인한 고액 삭감을 사전에 예방하고자 정보전산팀과 협의하여 「항암프로토콜 시작일 조회」 프로그램을 개발하였고, 이로 인해 삭감 예측 건에 대한 선제적 대응 조치가 가능하여 항암제 처방으로 인한 삭감액을 크게 줄일 수 있었다. 그리고 현재는 혈액종양내과에 한해서만 시행되고 있지만 향후 모든 진료과에 확대 적용을 목표로 하고 있어, 점차적으로 기대효과가 클 것으로 예상되어 우수 업무 사례로 소개하고, 지속적으로 추진될 수 있도록 독려하였다.

하지만 이번 정기감사를 통해 보험관리팀 업무 전반을 살펴본 결과, 대부분의 업무는 관련 법령 및 병원 규정에 맞게 이행되고 있었으나, ‘◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 심사불능 건에 관한 사항’ 외 7건의 지적사항에 대해서는 향후 이러한 일이 재발하지 않도록 시정·개선·권고·통보로 처분 요구하였다.

## IV 처분요구와 통보사항

### 1. 처분요구사항 일람표

| 일련<br>번호 | 감사대상<br>부 서 | 건 명                                 | 처분요구         |             |             | 조치<br>기한      | 비고 |
|----------|-------------|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----|
|          |             |                                     | 처분<br>종류     | 재정상<br>조치금액 | 신분상<br>조치인원 |               |    |
| 1        | 보험관리팀       | ◇◇◇◇◇◇◇◇ 심사불능 건에 관한<br>사항           | 권고           | -           | -           | 처분 후<br>2개월 내 | -  |
| 2        |             | 자동차보험 환자진료비 미수금 관<br>리 미흡           | 통보           | -           | -           | "             | -  |
| 3        |             | 비급여·요양급여 100/100(전액본<br>인부담)에 관한 사항 | 권고           | -           | -           | "             | -  |
| 4        |             | 퇴원 후 진료비 조정에 관한 사항                  | 개선<br>요구     | -           | -           | "             | -  |
| 5        |             | 진료비 고액 삭감 관리에 관한 사항                 | 개선<br>요구     | -           | -           | "             | -  |
| 6        |             | 산정특례 적용 착오 건 관리에 관<br>한 사항          | 권고           | -           | -           | "             | -  |
| 7        |             | HLA교차시험 검사비 입금 관리<br>미흡             | 통보<br>(시정완료) | -           | -           | "             | -  |
| 8        |             | 보험관리팀 소관 규정 관리에 관<br>한 사항           | 개선<br>요구     | -           | -           | "             | -  |

### 2. 처분요구상세

# 부 산 대 학 교 병 원

## 권 고

제 목 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 심사불능 건에 관한 사항

소관부서 양산부산대학교병원 보험관리팀

조치부서 양산부산대학교병원 보험관리팀

내 용

### 1. 업무개요

양산부산대학교병원 보험관리팀에서는 관련 법령 및 병원 규정·지침·정책에 따라 진료비 심사·청구·조정에 관한 업무를 수행하고 있으며, 요양적정성평가 및 의료질평가 등에 관한 업무도 담당하고 있다.

### 2. 관련근거(판단근거)

◇◇◇◇◇◇◇◇◇에서는 요양기관이 진료비 청구 시 필수 기재 사항을 누락하거나 기재 내용에 오류가 있는 경우, 또는 요양기관이 청구 후 오류를 인지하여 반송을 요청한 경우 등 심사 진행이 불가능한 건에 대해 「심사불능」으로 분류하고 해당 청구 건은 요양기관에 반송처리하고 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제

보험관리팀은 최근 3년간 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇으로부터 요양급여비용 ‘심사불능’ 사유로 총 2,882건(11,815,278,740원)을 반송받았다. 이 중 아래 [표]와 같이 기관요청 또는 자료미제출로 인해 반송된 건수가 1,449건(7,260,929,330원)으로 확인되었다.

**[표] 기관요청 및 자료미제출 반송 현황**

| 구분    | 2022년 |               | 2023년 |               | 2024년 |               |
|-------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
|       | 건수    | 금액(원)         | 건수    | 금액(원)         | 건수    | 금액(원)         |
| 기관요청  | 319   | 873,657,790   | 129   | 684,464,620   | 118   | 1,048,899,480 |
| 자료미제출 | 253   | 1,236,838,930 | 315   | 1,499,747,850 | 315   | 1,917,320,660 |
| 합계    | 572   | 2,110,496,720 | 444   | 2,184,212,470 | 433   | 2,966,220,140 |

또한 기관요청에 의한 반송 건 중 99건(23,172,920원)은 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇으로부터 반송명세서가 도착하기 이전에 재청구가 이루어져 중복청구로 인한 재반송이 발생한 사실도 있다.

반송 건의 경우 재청구를 통해 진료비를 지급받고 있으나, 불능 사유에 따른 보완자료 제출, 명세서 재작성 등 처리 과정에서 추가적인 행정 업무가 발생하며, 재청구로 인한 진료비 입금 지연은 병원 수익에도 영향을 미친다. 이에 따라 청구 단계에서부터 ① 착오청구, ② 전산입력 오류, ③ 소명자료 누락 등 단순 오류로 인한 반송이 발생하지 않도록 관리 할 필요가 있다.

#### 4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

보험관리팀에서는 기관요청 및 자료미제출에 따른 반송 건이 줄어들 수 있도록 지속적으로 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

**조치할 사항** 양산부산대학교병원장은

심사불능 건에 대해 유형별로 원인을 분석하여 향후 동일한 사례가 재발하지 않도록하고, 진료비 반송으로 인한 청구 지연이 발생하지 않도록 관련 업무에 만전을 기해 주시기 바랍니다. (권고)

# 부 산 대 학 교 병 원

## 통 보

제 목 자동차보험 환자진료비 미수금 관리 미흡

소관부서 양산부산대학교병원 보험관리팀

조치부서 양산부산대학교병원 보험관리팀

내 용

### 1. 업무개요

양산부산대학교병원 보험관리팀에서는 관련 법령 및 병원 규정·지침·정책에 따라 진료비 심사·청구·조정에 관한 업무를 수행하고 있으며, 요양적정성평가 및 의료질평가 등에 관한 업무도 담당하고 있다.

### 2. 관련근거(판단근거)

| 관련법령               | 세부 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 자동차손해배상 보장법        | 제12조(자동차보험진료수가의 청구 및 지급)<br>④ 제2항에 따라 의료기관이 자동차보험진료수가를 청구하면 보험회사등은 30일 이내에 그 청구액을 지급하여야 한다. 다만, 보험회사등이 제12조의2 제1항에 따라 위탁한 경우 전문심사기관이 심사결과 통지한 날부터 14일 이내에 심사결과에 따라 자동차보험진료수가를 지급하여야 한다.<br>제12조위2(업무의 위탁)<br>① 보험회사등은 제12제4항에 따라 의료기관이 청구하는 자동차보험진료수가의 심사·조정 업무등을 대통령령으로 정하는 전문심사기관에 위탁할 수 있다. |
| 자동차손해배상 보장법<br>시행령 | 제11조의2(자동차보험진료수가전문심사기관)<br>제12조의2제1항에서 “대통령령으로 정하는 전문심사기관”이란 「국민건강보험법」 제62조에 따른 ◇◇◇◇◇◇◇◇을 말한다.<br>제16(진료수가의 지급에 관한 이자율)<br>① 보험회사등은 법 제12조제4항 본문에 따른 지급기한을 넘겨 청구액을 지급하는 경우에는 연 20퍼센트의 이자율을 적용하여 지급한다.                                                                                          |

### 3. 감사결과 확인된 문제

최근 3년간(2022.1.1.~2024.12.31.) 발생한 자동차보험 환자진료비 미수금에 대해 검토한 결과 아래 [표]와 같이 ■■■■■■■■■■을 포함한 8개 보험사로부터 지급기한을 초과하여 환자진료비가 입금된 사실이 있다.

**[표] 자동차보험 환자진료비 미수금 지연 입금 현황**

| 자보사명 | 진료년월    | 등록번호 | 환자명 | 청구액       | 미수액       | 통보일자       | 입금액       | 입금일자       | 지연<br>일수 |
|------|---------|------|-----|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
| 비공개  | 2022-01 | 비공개  | 비공개 | 27,670    | 27,670    | 2022-05-02 | 27,670    | 2022-09-20 | 127      |
|      | 2022-01 |      |     | 58,610    | 58,610    | 2022-03-11 | 58,610    | 2022-03-30 | 5        |
|      | 2022-01 |      |     | 756,690   | 756,690   | 2022-03-11 | 756,690   | 2022-03-30 | 5        |
|      | 2022-01 |      |     | 55,340    | 55,340    | 2022-03-11 | 55,340    | 2022-03-30 | 5        |
|      | 2022-02 |      |     | 344,770   | 344,770   | 2022-04-15 | 344,770   | 2022-05-03 | 4        |
|      | 2022-02 |      |     | 23,170    | 23,170    | 2022-04-15 | 23,170    | 2022-06-17 | 49       |
|      | 2022-02 |      |     | 51,590    | 51,590    | 2022-04-15 | 51,590    | 2022-05-13 | 14       |
|      | 2022-02 |      |     | 45,680    | 45,680    | 2022-04-15 | 45,680    | 2022-05-03 | 4        |
|      | 2022-03 |      |     | 91,980    | 91,980    | 2022-05-16 | 91,980    | 2022-06-03 | 4        |
|      | 2022-04 |      |     | 84,200    | 84,200    | 2022-06-15 | 84,200    | 2022-07-20 | 21       |
|      | 2022-04 |      |     | 107,230   | 107,230   | 2022-06-15 | 107,230   | 2022-07-01 | 2        |
|      | 2022-04 |      |     | 547,640   | 547,640   | 2022-06-15 | 547,640   | 2022-09-20 | 83       |
|      | 2022-04 |      |     | 50,840    | 50,840    | 2022-06-15 | 50,840    | 2022-07-01 | 2        |
|      | 2022-04 |      |     | 46,340    | 46,340    | 2022-06-15 | 46,340    | 2022-07-01 | 2        |
|      | 2022-06 |      |     | 119,480   | 119,480   | 2022-08-08 | 119,480   | 2022-08-25 | 3        |
|      | 2022-06 |      |     | 23,170    | 23,170    | 2022-08-08 | 23,170    | 2022-08-31 | 9        |
|      | 2022-07 |      |     | 40,890    | 40,890    | 2022-09-15 | 40,890    | 2022-09-30 | 1        |
|      | 2022-07 |      |     | 2,579,610 | 2,481,240 | 2022-09-15 | 2,481,240 | 2022-10-24 | 25       |
|      | 2022-07 |      |     | 39,710    | 39,710    | 2022-09-15 | 39,710    | 2022-09-30 | 1        |
|      | 2022-12 |      |     | 40,050    | 40,050    | 2023-02-13 | 40,050    | 2023-02-28 | 1        |
|      | 2022-12 |      |     | 486,690   | 486,690   | 2023-02-13 | 486,690   | 2023-02-28 | 1        |
|      | 2022-12 |      |     | 27,670    | 27,670    | 2023-02-13 | 27,670    | 2023-03-03 | 4        |
|      | 2022-12 |      |     | 23,170    | 23,170    | 2023-02-13 | 23,170    | 2023-03-03 | 4        |
|      | 2023-06 |      |     | 479,230   | 406,810   | 2023-08-11 | 406,810   | 2023-09-20 | 26       |
|      | 2023-07 |      |     | 36,020    | 36,020    | 2023-09-12 | 36,020    | 2023-10-20 | 24       |
|      | 2023-08 |      |     | 888,810   | 884,470   | 2023-10-12 | 884,470   | 2023-11-07 | 12       |

또한 진료비 지연 입금과 관련하여 각 보험사에 독촉 공문을 발송하고 있으나, 공문에는 지연이자에 대한 내용이 포함되지 않아 보험사로부터 지연이자는 미수령 된 것으로 확인되었다.

#### 4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

보험관리팀에서는 자동차보험 환자 미수금 관리를 철저히 하여 향후에는 지연 입금되는 일이 없도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 양산부산대학교병원장은

향후 동일한 사례가 재발하지 않도록 자동차보험 환자 미수금 관리에 철저를 기해 주시기 바랍니다. (통보)

# 부 산 대 학 교 병 원

## 권 고

제 목 비급여·요양급여100/100(전액본인부담)에 관한 사항

소관부서 양산부산대학교병원 보험관리팀

조치부서 양산부산대학교병원 보험관리팀

내 용

### 1. 업무개요

양산부산대학교병원 보험관리팀에서는 관련 법령 및 병원 규정·지침·정책에 따라 진료비 심사·청구·조정에 관한 업무를 수행하고 있으며, 요양적정성평가 및 의료질평가 등에 관한 업무도 담당하고 있다.

### 2. 관련근거(판단근거)

「국민건강보험법 시행령」 제22조(약제·치료재료의 요양급여비용) 및 「국민건강보험법 요양급여의기준에 관한 규칙」 제5조(요양급여의 적용기준 및 방법) 1항의 「별표1」을 적용하며, 그 세부사항은 ㉞㉞㉞㉞㉞장관이 정하여 고시한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제

‘전액본인부담(100/100)’이란 국민건강보험법 시행규칙 제16조에 의거 별도로 고시된 항목으로, 해당 항목에 대해서는 요양급여비용 전액(100%)을 환자가 부담하는 것을 의미하며, ‘인정 비급여’란 ㉞㉞㉞㉞㉞가 특정 치료의 필요성을 인정하였으나 급여 대상에 포함하지 않아 비급여로 분류한 항목을 말한다.

이에 대해 최근 3년간 보험관리팀의 삭감 상세 내역을 검토한 결과, 아래 [표]와 같이 비급여 또는 전액본인부담 항목임에도 불구하고 진료비를 환자에게 청구하지 않고 건강보험 급여로 청구하여 삭감된 사실이 확인되었다.

**[표] 비급여·요양급여100/100본인부담 항목 삭감 현황**

| 구분 | 2022년 |            | 2023년 |            | 2024년 |             | 삭감조정코드 및 항목                                                              |
|----|-------|------------|-------|------------|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
|    | 건수    | 금액(원)      | 건수    | 금액(원)      | 건수    | 금액(원)       |                                                                          |
| 입원 | 452   | 44,574,803 | 612   | 26,154,328 | 800   | 84,337,700  | 삭감조정코드: E, TE<br>항목: 투약료, 주사료,<br>검사료, 수술료, MRI, PET<br>이학요법, 진찰료, 마취료 등 |
| 외래 | 305   | 49,956,008 | 213   | 34,373,562 | 360   | 52,765,772  |                                                                          |
| 합계 | 757   | 94,530,811 | 825   | 60,527,890 | 1,160 | 137,103,472 |                                                                          |

\* E: 비급여 또는 요양급여비용의 100분의100본인부담항목 조정

TE: 비급여 또는 100분의100본인부담대상청구(요양급여비용총액과 100분의100미만 총액 해당)

삭감금액과 관련하여, 이미 급여로 진료비를 수납한 환자에게 이를 다시 징수하는 것은 사전 설명 부족 등의 이유로 현실적으로 어려운 상황이다. 따라서 각 진료과에 지속적으로 관련 내용을 안내하여 반복적인 삭감을 방지하고, 진료비 심사 시에도 적용기준을 반영하는 등 해당 항목에 대하여 적극적으로 관리 할 필요가 있다.

#### 4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

비급여 및 요양급여100/100(전액본인부담) 적용이 가능한 항목들에 대해 각 진료과 공지 및 환자에게 사전 설명이 충분히 이루어지도록 하고, 진료과와 협의하여 삭감 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

#### 조치할 사항 양산부산대학교병원장은

각 진료과를 대상으로 비급여·요양급여100/100(전액본인부담) 적용이 가능한 항목에 대해 사전 공지 하고, 반복적인 삭감이 발생하지 않도록 조치하는 등, 진료과와 협의하여 실효성 있는 대책을 마련해 주시기 바랍니다. (권고)

# 부 산 대 학 교 병 원

## 개 선 요 구

제 목 퇴원 후 진료비 조정에 관한 사항

소관부서 양산부산대학교병원 보험관리팀

조치부서 양산부산대학교병원 보험관리팀

내 용

### 1. 업무개요

양산부산대학교병원 보험관리팀에서는 관련 법령 및 병원 규정·지침·정책에 따라 진료비 심사·청구·조정에 관한 업무를 수행하고 있으며, 요양적정성평가 및 의료질평가 등에 관한 업무도 담당하고 있다.

### 2. 관련근거(판단근거)

보험관리팀에서는 퇴원이 완료된 환자 중 퇴원 후 처방 누락으로 인한 수가 추가, 검사 미실시로 인한 처방 반납, 수가 산정 및 청구 오류, 병리검사 추가, 급종 변경 등 다양한 사유가 발생한 경우, 해당 내용을 원무팀에 통보하고 환불 또는 환수 처리를 요청하고 있으며, 이후 재심사 및 재정산 절차를 거쳐 진료비 청구를 진행하고 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제

최근 3년간 퇴원 후 진료비 조정 발생 현황은 아래 [표 1]과 같다.

**[표 1] 퇴원 후 진료비 조정 현황**

(단위: 건)

| 구분    | 청구 전 발생 건수 | 청구 후 발생 건수 | 총 건수  |
|-------|------------|------------|-------|
| 2022년 | 835        | 206        | 1,041 |
| 2023년 | 890        | 139        | 1,029 |
| 2024년 | 958        | 342        | 1,300 |
| 총 건수  | 2,683      | 687        | 3,370 |

\* 환의반납, 진단서 수정 제외

이와 관련하여 퇴원 후 진료비 조정이 발생한 건을 검토한 결과 아래와 같은 문제점이 확인되었다.

① 진료비 조정 발생 건에 대해 원무팀으로 통보 할때 전자문서가 아닌 구두 또는 메신저를 통해 업무가 처리되어, 그룹웨어 문서상에서는 해당 업무 처리 내역을 확인할 수 없었으며, ② 청구 전 조정 발생건에 대한 진료비 청구 내역을 살펴본 결과, [표 2]와 같이 총 1,556건이 퇴원일 기준 최소 31일 ~ 최대 443일 지연되어 청구 된 것으로 확인되었다.

**[표 2] 청구 전 발생건 진료비 지연 청구 현황**

(단위: 건)

| 구분 | 30일 이상 지연 | 100일 이상 지연 | 365일 이상 지연 | 합계    |
|----|-----------|------------|------------|-------|
| 건수 | 1,486     | 68         | 2          | 1,556 |

\* 상급종합병원 구조전환 수가 관련 제외

따라서 퇴원 후 조정 건에 대한 재심사 및 재정산 절차가 누락되지 않도록 전자문서를 통해 체계적으로 업무를 처리하고, 진료비 수익과 관련된 조정 발생 건수를 최소화하여 진료비가 적시에 청구될 수 있도록 개선이 요구된다.

#### 4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

보험관리팀에서는 전자문서를 통해 업무를 처리하고 퇴원 후 조정 건이 감소할 수 있도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

#### 조치할 사항 양산부산대학교병원장은

퇴원 후 진료비 조정과 관련하여 원무팀 통보 시 전자문서를 통한 업무처리로 절차를 개선하고, 진료비 조정 발생 건수를 최소화할 수 있도록 업무를 관리해주시기 바랍니다. (개선 요구)

# 부 산 대 학 교 병 원

## 개 선 요 구

제 목 진료비 고액 삭감 관리에 관한 사항

소관부서 양산부산대학교병원 보험관리팀

조치부서 양산부산대학교병원 보험관리팀

내 용

### 1. 업무개요

양산부산대학교병원 보험관리팀에서는 관련 법령 및 병원 규정·지침·정책에 따라 진료비 심사·청구·조정에 관한 업무를 수행하고 있으며, 요양적정성평가 및 의료질평가 등에 관한 업무도 담당하고 있다.

### 2. 관련근거(판단근거)

- ◇ 국민건강보험법 제87조(이의신청) 제3항, 의료급여법 제30조(이의신청 등) 제3항에 따르면 이의신청의 경우 처분이 있음을 안 날로부터 90일 이내에 하여야 하며, 자동차손해배상 보장법 제19조(자동차보험진료수가의 심사 청구 등) 제1항에 따르면 심사결과에 이의가 있는 때에는 이의제기 결과를 통보받은 날부터 30일 이내에 심의회에 그 심사를 청구할 수 있다고 규정되어 있다.
- ◇ 또한 부산대학교병원 행정업무규정 제6조(문서의 성립 및 효력) 제2항에 따르면 문서는 수신자에게 도달됨으로써 그 효력이 발생하며, 제19조(문서의 수·발신방법 등) 제1항에서는 문서는 전자문서시스템 등을 이용하여 발신 또는 수신하는 것을 원칙으로 한다고 명시되어 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제

보험관리팀은 ◇◇◇◇◇◇◇◇ 진료비 심사 결과 고액 삭감이 발생하였을 경우 해당 진료과에 관련 내용을 통지하여야 하며, 각 진료과에서 이의가 있는 경우 관련 법령에 따라 정해진 기한 내 이의신청을 제기하여 삭감률을 최소화할 수 있도록 노력하여야 한다.

위와 관련하여 2019년 정기감사에서 「진료비 고액 삭감관리 및 진료과 고지에 관한 사항」을 지적받아 향후 고액삭감에 대한 교육 및 기존의 유선, 그룹웨어 메일, SMS를 통한 공지 외에도 해당 진료과(진료의)에 삭감 내역을 공문으로 통보하여 관리하겠다는 이행계획을 제출한 바 있다. 이에 대한 이행 현황을 확인하고자 최근 3년간(2022. 1. 1.~2024. 12. 31.) 보험관리팀 전체 진료비 청구 내역을 검토한 결과, 아래 [표 1]과 같이 전체 삭감액 대비 고액 삭감의 비율이 다소 높게 나타났다.

**[표 1] 진료비 고액(100만원 이상)삭감 현황**

(단위: 원, %)

| 구분    | 총 삭감액         | 고액 삭감액        | 비율   | 비고 |
|-------|---------------|---------------|------|----|
| 2022년 | 1,338,448,886 | 713,503,663   | 53.3 |    |
| 2023년 | 1,692,078,855 | 1,242,949,775 | 73.4 |    |
| 2024년 | 1,551,338,832 | 740,285,867   | 47.7 |    |

이에 고액 삭감 내역이 각 진료과에 공문으로 통지되고 있는지를 확인하고자 그룹웨어 내 관련 문서를 살펴본 결과, 아래 [표 2]와 같이 총 130건에 대해 해당 진료과에 통보되지 않은 사실이 확인되었다.

**[표 2] 진료비 고액 삭감(100만원 이상) 미통보 내역**

(단위: 건, 원)

| 년도   | 진료과      | 건수  | 삭감액         | 심사자 |
|------|----------|-----|-------------|-----|
| 2022 | 순환기내과    | 2   | 3,320,830   | 비공개 |
|      | 신장내과     | 1   | 1,457,180   |     |
|      | 혈액종양내과   | 6   | 13,197,118  |     |
|      | 류마티스내과   | 4   | 9,549,160   |     |
|      | 신경과      | 3   | 4,279,020   |     |
|      | 외과       | 6   | 8,079,950   |     |
|      | 신경외과     | 20  | 48,833,770  |     |
|      | 심장혈관흉부외과 | 2   | 10,280,340  |     |
|      | 소아청소년과   | 1   | 1,918,190   |     |
|      | 산부인과     | 2   | 2,776,050   |     |
|      | 비뇨의학과    | 1   | 1,523,990   |     |
|      | 안과       | 2   | 2,423,360   |     |
|      | 재활의학과    | 6   | 9,612,343   |     |
|      | 응급의학과    | 1   | 2,768,550   |     |
| 2023 | 소화기내과    | 7   | 14,888,380  |     |
|      | 순환기내과    | 6   | 9,869,740   |     |
|      | 호흡기내과    | 1   | 1,937,010   |     |
|      | 혈액종양내과   | 1   | 1,620,000   |     |
|      | 신경과      | 1   | 1,321,130   |     |
|      | 외과       | 9   | 12,648,540  |     |
|      | 신경외과     | 21  | 53,963,030  |     |
|      | 심장혈관흉부외과 | 7   | 16,336,860  |     |
|      | 소아청소년과   | 3   | 3,574,900   |     |
|      | 산부인과     | 6   | 10,603,130  |     |
|      | 성형외과     | 2   | 2,793,260   |     |
|      | 정형외과     | 1   | 1,226,971   |     |
|      | 재활의학과    | 3   | 5,765,190   |     |
|      | 응급의학과    | 5   | 6,119,313   |     |
| 총 계  |          | 130 | 262,687,305 |     |

또한 전자문서의 경우 수신자(진료과)에게 협조문 형식으로 발송하는 것이 원칙임에도, 아래 [표 3]과 같이 그룹웨어 내 내부결재 문서로만 처리되어 실제 문서 수신 여부를 확인할 수 없는 건수도 다수 발견되었다.

**[표 3] 진료비 고액 삭감 통보 문서 미발송 내역**

(단위: 건)

| 연도   | 건수 | 문서 구분 | 문서 도달(수신) 여부 | 비고 |
|------|----|-------|--------------|----|
| 2022 | 3  | 내부결재  | 그룹웨어 내 확인 불가 |    |
| 2023 | 13 | 내부결재  | 그룹웨어 내 확인 불가 |    |
| 2024 | 20 | 내부결재  | 그룹웨어 내 확인 불가 |    |

따라서 병원 수익과 직결되는 삭감을 감소시키기 위해 고액 삭감 고지 및 이의신청과 관련한 업무 절차를 부서 내에 명확히 확립해야 할 것이며, 이를 통해 진료과와의 협조 체계를 강화하여 삭감 관리를 개선해야 할 필요성이 있다.

#### 4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

보험관리팀에서는 삭감을 관리하기 위해 진료비 고액 삭감 관련 고지 및 이의신청 업무 절차를 부서 내부적으로 개선할 것이며, 문서 발송 등에 관한 관련 규정을 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

**조치할 사항** 양산부산대학교병원장은

보험관리팀에서 진료비 고액 삭감 관련 고지 및 이의신청 업무 절차를 내부적으로 개선하여 삭감 관리를 할 수 있도록 조치하여 주시고, 규정을 준수하여 업무를 수행하도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다. (개선 요구)

# 부 산 대 학 교 병 원

## 권 고

제 목 산정특례 적용 착오 건 관리에 관한 사항

소관부서 양산부산대학교병원 보험관리팀

조치부서 양산부산대학교병원 보험관리팀

내 용

### 1. 업무개요

양산부산대학교병원 보험관리팀에서는 관련 법령 및 병원 규정·지침·정책에 따라 진료비 심사·청구·조정에 관한 업무를 수행하고 있으며, 요양적정성평가 및 의료질평가 등에 관한 업무도 담당하고 있다.

### 2. 관련근거(판단근거)

#### 국민건강보험법 시행령

##### □ 제19조 제1항 [별표2] 제3호 마목

중증질환자에 대하여 ㉔㉔㉔㉔㉔장관이 정하는 요양급여(라목에 해당하는 사람에 대한 요양급여는 제외한다)의 경우에는 요양급여비용총액의 100분의 5에 입원기간 중 식대의 100분의 50을 더한 금액

##### □ 제19조 제1항 [별표2] 제3호 나목

다음의 경우(라목에 해당하는 사람에 대한 요양급여는 제외한다)에는 요양급여비용총액의 100분의 10에 입원기간 중 식대의 100분의 50을 더한 금액

1) 생략

2) ㉔㉔㉔㉔㉔장관이 정하여 고시하는 희귀난치성 질환을 가진 사람에 대하여

ⓂⓂⓂⓂⓂ장관이 정하는 요양급여

3)~4) 생략

☐ 본인일부부담금 산정특례에 관한 기준: [별표1~4]에 따라 적용기간 정함

### 3. 감사결과 확인된 문제

2019년 양산부산대학교 보험관리팀 정기감사에서 지적된 「외래산정특례 적용 착오 건 관리에 관한 사항」에 대한 이행 현황을 확인하고자, 최근 3년간 (2022.1.1.~2024.12.31.) 발생한 외래 산정특례 적용 착오 건수를 검토한 결과, [표 1]과 같이 오히려 착오 건수가 증가한 것으로 확인 되었다.

이에 대한 원인을 살펴본 결과 착오 건수 증가 요인 중 하나는 **환자들의 무인 수납기 이용률 증가**로 확인되었는데, 이는 현재 운영 중인 무인 수납기가 창구 수납과 달리 산정특례 적용 여부를 판단하여 수납 여부를 결정 할 수 없는 구조이기 때문이다. 따라서 이와 같은 시스템적 한계가 개선되지 않을 경우, 향후 보험관리팀 사후 심사 및 원무팀 재정산 등 후속 행정업무가 지속적으로 증가할 것이며 이로 인해 업무 효율성이 저하되고 인력 운영에도 부담이 가중될 수 있다.

**[표 1] 외래 산정특례 적용 착오 건수 비교**

| 구분 | 2019년 정기감사 |       |       |       | 2025년 정기감사 |       |       |       | 비고       |
|----|------------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|----------|
|    | 2016년      | 2017년 | 2018년 | 3년 평균 | 2022년      | 2023년 | 2024년 | 3년 평균 |          |
| 건수 | 1,276      | 871   | 595   | 914   | 2,116      | 1,755 | 1,155 | 1,675 | 약 1.8배 ↑ |

그리고 입원의 경우에는 2019년 정기감사에서 별도의 지적사항이 없어 비교 검토는 하지 않았으나, [표 2]와 같이 연도별 증가 추세를 보이고 있다.

**[표 2] 입원 산정특례 적용 착오 건수**

| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 비고          |
|----|-------|-------|-------|-------------|
| 건수 | 14    | 24    | 27    | 연도별 착오건수 증가 |

다음으로 산정특례 적용 착오 건에 대한 재정산 및 청구가 적정한 기간 내에 처리되고 있는지도 확인한 결과, [표 3]과 같이 진료비 청구가 60일 이후 처리된 건(입원 22건, 외래 654건)이 다수 있었으며, 이 중 최대 지연 일수는 입원 671일, 외래 643일로 나타났다.

**[표 3] 산정특례 착오로 인한 청구 지연 현황**

| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 비고                        |
|----|-------|-------|-------|---------------------------|
| 입원 | 6     | 6     | 10    | 62일~671일 지연<br>(퇴원일자 기준)  |
| 외래 | 213   | 315   | 126   | 61일~643일 지연<br>(진료종료일 기준) |

이와 같이 산정특례 착오로 발생하는 부정적인 영향은 병원의 수입과 직접적으로 연관이 있을 뿐만 아니라, 병원에 대한 신뢰도 저하로도 이어질 수 있음에 따라 관련 부서 간 신속한 협의를 통해 실효성 있는 개선 방안을 마련할 필요가 있다.

#### 4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

보험관리팀에서는 현행 문제점을 해결할 방안에 대하여 관련부서와 협의하여 산정특례 착오 건이 최소화될 수 있도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 양산부산대학교병원장은

산정특례 적용 여부 확인이 필수적으로 이루어질 수 있도록 교육 및 시스템을 강화하고, 현행 문제점에 대해서는 관련부서와 충분히 협의하여 산정특례 적용 착오를 최소화할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. (권고)

# 부 산 대 학 교 병 원

## 통 보(시정완료)

제 목 HLA교차 시험 검사비 입금 관리 미흡

소관부서 양산부산대학교병원 보험관리팀

조치부서 양산부산대학교병원 보험관리팀

내 용

### 1. 업무개요

양산부산대학교병원 보험관리팀에서는 관련 법령 및 병원 규정·지침·정책에 따라 진료비 심사·청구·조정에 관한 업무를 수행하고 있으며, 요양적정성평가 및 의료질평가 등에 관한 업무도 담당하고 있다.

### 2. 관련근거(판단근거)

#### 입금 요청 공문

- \* 보험관리팀-2096(2022.04.26.), '뇌사자-기증자간 HLA교차시험 검사비 입금 요청'
- \* 보험관리팀-5369(2022.10.14.), '뇌사자-기증자간 HLA교차시험 검사비 입금 요청'
- \* 보험관리팀-6943(2022.12.28.), '뇌사자-기증자간 HLA교차시험 검사비 입금 요청'
- \* 보험관리팀-7020(2022.12.30.), '뇌사자-기증자간 HLA교차시험 검사비 입금 요청'

- 뇌사장기관리료는 장기기증을 동의한 날로부터 적출까지 발생한 비용 중 뇌사판정의료기관 혹은 뇌사판정기관 이송비(인건비 포함), 장기기증 상담 및 코디네이터관리비, 뇌사판정비, HLA교차시험<sup>2)</sup> 검사비가 포함된 비용으

로써 수혜자가 ㉠㉠㉠㉠㉠㉠㉠㉠에 부담하는 비용임.

- 따라서 병원에서 실시한 HLA교차시험 검사비는 뇌사장기관리료 안에 포함된 수가임에 따라 ㉠㉠㉠㉠㉠㉠㉠㉠에 비용 청구하고 있음.

### 3. 감사결과 확인된 문제

최근 3년간(2022.1.1.~2024.12.31.) 발생한 HLA교차시험 검사비 입금요청 내역 중 병원으로 미입금된 내역이 있는지 확인하고자 회계관리팀으로 통보한 문서를 살펴본 결과, 총 198건 중 194건은 병원에 입금처리가 완료되었으나 [표]와 같이 2022년도에 입금 요청한 4건은 감사일 현재(2025.07.09.)까지도 입금처리가 완료되지 않아 해당기관에 재요청하여 검사비가 입금될 수 있도록 조치하였다.

[표] HLA교차시험 검사비 미입금 내역

| NO | 검사 일자       | 기증자 | 수혜자 | 입금요청액    | 요청 일자       | 입금 요청기관 | 비고                                    |
|----|-------------|-----|-----|----------|-------------|---------|---------------------------------------|
| 1  | 2022.03.10. | 비공개 | 비공개 | 155,246원 | 2022.04.26. | 비공개     | 감사기간 내<br>입금처리<br>완료<br>(2025.07.10.) |
| 2  | 2022.06.09. |     |     | 155,246원 | 2022.10.14. |         |                                       |
| 3  | 2022.10.07. |     |     | 155,246원 | 2022.12.28. |         |                                       |
| 4  | 2022.12.09. |     |     | 145,692원 | 2022.12.30. |         |                                       |
| 합계 |             |     |     | 611,430원 |             |         |                                       |

### 4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

보험관리팀에서는 입금관리를 철저히 하여 향후에는 누락되는 일이 없도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

2) HLA교차시험: 공여자-수혜자 간 혈액을 섞어서 거부반응이 생기는지 보는 검사

조치할 사항 양산부산대학교병원장은

감사 현지조치에 따라 미입금된 HLA교차시험 검사비를 재청구하여 2025. 7. 10.자에 입금처리를 완료하였으나, 향후에는 유사 사례가 재발하지 않도록 업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다. (통보-시정완료)

# 부 산 대 학 교 병 원

## 개 선 요 구

제 목 보험관리팀 소관 규정 관리에 관한 사항

소관부서 양산부산대학교병원 보험관리팀

조치부서 양산부산대학교병원 보험관리팀

내 용

### 1. 업무개요

양산부산대학교병원 보험관리팀에서는 관련 법령 및 병원 규정·지침·정책에 따라 진료비 심사·청구·조정에 관한 업무를 수행하고 있으며, 요양적정성평가 및 의료질평가 등에 관한 업무도 담당하고 있다.

### 2. 관련근거(판단근거)

#### ① 제규정관리규정

##### 제1조(목적)

이 규정은 부산대학교병원(이하 · 병원 · 이라 한다)의 규정·세칙·지침 등의 제정·개정·폐지·시행 및 관리에 필요한 사항을 규정함으로써 제규정의 운용관리에 적정을 기함을 목적으로 한다.

##### 제2조(정의)

이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "제규정"이라 함은 병원의 조직·인사·복무·업무수행방침·절차 등에 관한 규정·세칙·지침·기타 체계적인 규범의 형식을 갖춘 법규문서를 총칭한다.
2. "규정"이라 함은 법령 및 정관에 준거하여 병원의 조직과 직원의 권리·의무 및 업무의 관리운영에 관한 기본적인 방침·기준 등을 정한 것을 말한다.
3. "세칙" 이라 함은 규정에서 위임된 사항과 시행에 필요한 세부사항 또는 각 부문의 업무 운영기준 및 절차 등을 정한 것을 말한다. (이하생략)

## ② 진료수가규정시행세칙

### 제5조(수가책정방법)

9. 신규수가는 [별첨3]에 의하여 책정한다.

#### [별첨3] 신규수가 책정방법

<요양급여·비급여·신의료기술·산정불가 공통> (생략) 신규수가의 경우 수가소위원회에서 심의·의결 후 기조실장, 사무국장, 진료부원장, 원장 결재 후 시행한다.

### 제7조(수가책정 절차)

3. 약제 및 치료재료 수가 (이하생략)

### 제11조(수가심의소위원회 구성)

② 위원장은 진료지원실장이 되고, 당연직 위원은 원무팀장, 기획예산팀장, 물류관리팀장, 특수간호 2팀장, 중앙공급실 UM, 보험관리팀장으로 하고, 수술을 하는 외과계 교수를 포함하여 원장이 지명하는 3인 이내의 위원으로 구성한다.

### 제12조(수가심의소위원회 기능)

3. 치료재료 수가책정에 관한 사항

## ③ 위임전결시행세칙

### [별표 1] 전결 사항

| 해당부서  | 업 무 명     | 세 부 업 무 내 용                                                                                                                                                               | 양산<br>병원장                   | 전 결 권 자           |             |
|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|
|       |           |                                                                                                                                                                           |                             | 부원장·처장·<br>본부장·국장 | 과/팀장        |
| 보험관리팀 | 1. 진료비 심사 | 1) 건강보험·의료급여 심사기구설치 및 운영<br>2) 건강보험·의료급여 자체심사 결과보고<br><b>3) 진료비에 대한 이의신청</b><br>4) 건강보험·의료급여 환자 진료내역 보완<br>5) 건강보험·의료급여 진료비 증감조정<br>6) 소명자료 제출<br>7) 건강보험·의료급여 진료비 삭감액 처리 | ◦<br>◦<br><br><br><br><br>◦ | ◦                 | ◦<br>◦<br>◦ |

### 3. 감사결과 확인된 문제

「부산대학교병원 제규정관리규정」에서는 제규정의 체계적이고 효율적인 운용 및 관리를 위해 관련 내용을 현행에 맞도록 정비하고, 제·개정 및 폐기가 적절하게 이루어져야 함을 명시하고 있다.

위와 관련하여 보험관리팀 소관 규정 및 시행세칙을 살펴본 결과 [표 1]과 같이 ① 기관 명칭 오류가 있어 현행 명칭<sup>3)</sup>으로 수정이 필요하였으며, 그리

3) 2010.07 ■■■■■로 개편, 2013.03 ■■■■■로 개편

고 본원과 달리 ② 진료재료 심의 업무가 ‘진료재료 도입심의 TFT’ 신설로 인해 기획예산팀으로 이관되어 운영됨<sup>4)</sup>에 따라 규정상 추가책정절차, 추가심의소위원회의 기능 및 위원회 구성에 변경이 있음에도 별도의 규정 제·개정 없이 자체 변경하여 운영<sup>5)</sup> 중이었다. 또한 ③ ‘진료비에 대한 이의신청’ 관련 업무의 경우 전결권자가 부원장임에도 진료지원실장으로 자체 조정하여 시행<sup>6)</sup> 하고 있어 관련 규정의 제·개정이 필요한 사실이 확인되었다.

**[표 1] 보험관리팀 소관 규정 관리 미흡 내역**

| 규 정 명      | 세부 조항                                              | 내용                                                                                                             | 비고 |
|------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 진료수가규정     | 제4조(추가책정) 제1항                                      | 기관 명칭 오류                                                                                                       |    |
| 진료수가규정시행세칙 | 제4조(추가책정기준)<br>제5조(추가책정방법)<br>제6조(추가책정시기)          |                                                                                                                |    |
|            | 제7조(추가책정절차)<br>3. 약제 및 치료재료 추가                     | 자체 변경 시행<br>(진료재료 도입심의 TFT로<br>진료재료 심의 업무 이관)                                                                  |    |
|            | 제12조(추가심의소위원회 기능)<br>3. 치료재료 추가책정에 관한 사항           | 자체 변경 시행<br>• 위원장: 진료지원실장<br>• 당연직: 기획조정실장,<br>원무팀장, 보험관리팀장<br>• 위원: 외과장, 내과장,<br>진단검사의학과장,<br>외래간호팀장, 특수간호2팀장 |    |
| 위임전결시행세칙   | [별표 1] 전결 사항(보험관리팀)<br>1. 진료비심사 3) 진료비에 대한<br>이의신청 | 자체 변경 시행<br>(전결권자<br>부원장→진료지원실장으로 변경)                                                                          |    |

마지막으로 진료수가규정시행세칙 [별첨3]에 의하면 신규수가 책정의 경우 수가소위원회에서 심의·의결 후 기조실장, 사무국장, 진료부원장, 원장 결재 후 시행하여야 함에도 최근 3년간(2022. 1. 1.~2024. 12. 31.) 보험관리팀에서 시행한 신규수가 책정 관련 문서를 살펴본 결과, [표 2]와 같이 수가 신규책정 및 조정 시 사무국장 결재 없이 처리한 사실이 확인되었다.

4) 기획예산팀-3354(2024.10.07.) 「진료재료 도입심의 TFT 지침 개정에 따른 변경사항 안내」

5) 보험관리팀-2023(2023.05.22.) 「추가심의소위원회 위원 구성 변경(안)」

6) 보험관리팀-6205(2019.08.22.) 「진료비에 대한 이의신청 관련 업무에 대한 전결 사항」

**[표 2] 보험관리팀 수가 신규책정 및 조정 내역**

| 연도   | 문서 제목                                              | 내용       | 비고   |
|------|----------------------------------------------------|----------|------|
| 2022 | 보험관리팀-548(2022.02.02.) 「비급여 수가 신규책정 및 조정(안)」 외 8건  | 사무국장 미결재 | 결재누락 |
| 2023 | 보험관리팀-690(2023.02.01.) 「비급여 수가 신규책정 및 조정(안)」 외 8건  | 사무국장 미결재 | 결재누락 |
| 2024 | 보험관리팀-1389(2024.03.04.) 「비급여 수가 신규책정 및 조정(안)」 외 7건 | 사무국장 미결재 | 결재누락 |

#### 4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

보험관리팀에서는 소관 규정을 현행에 맞게 보완하고 업무 수행 시 규정상 절차를 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

#### 조치할 사항 양산부산대학교병원장은

보험관리팀에서 소관 규정을 현행에 맞게 정비하여 운영할 수 있도록 조치하여 주시고, 업무 수행 시 규정상 절차를 준수하여 위반되는 일이 없도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다. (개선 요구)